

ちゃんは母親の糖のおおい血液に反応してインシュリンを多量に分泌し、それが赤ちゃんを巨大化し、肩がつかえ難産になる。28週(8カ月)以後は、入院させられることになる。36週(10カ月)をすぎると、赤ちゃんが外で十分にそだつ見込みのつき次第、早く出産させるため帝王切開をする。母親が低血糖になり生まれた子も低血糖になることもある。

妊娠前に糖尿病でなかったのに、妊娠してから血糖が高くなることがある。空腹時と食後に血糖をはかり、高血糖があつたら、妊娠糖尿病として、すぐ食餌療法をする。それでよくならぬ時はインシュリンが必要だ。たいてい出産とともになおる。

糖尿病がすでにながく、タンパク尿がでたり、目の網膜に異常のある人は、出産は無理である。

心臓の病気といえば、以前はリウマチ熱による弁膜症であつたが、リウマチ熱の治療がすすんで弁膜症をおこすのがほとんどなくなった。それにかわつて先天性の心臓病をもった人が妊娠できる年齢まで生存することがおこなつた。心臓外科が進歩したので、かなり重い先天性の心臓病もおおせるようになった。心臓の手術をした人は妊娠する前に(結婚がきまつたらといったほうがいい)、以前に手術してもらつた医者にみてもらうべきだ。心臓が完全にはたらいでないときは、流産や早産をおこしやすい、生まれた子が危険な状態になりやすい。妊娠と出産にたえられるかどうかを、心臓を専門にやっている医者はきめてくれるだろう。

手術をすすめられながら、手術がいやでのばして

いた人は、子どもがほしければ妊娠する前に手術しないといけない。心臓の専門家も、いままでの子どもをたすける治療から、親子をたすける治療に向かつて領域をひろげていかなければならない。

妊娠するとすぐに血液循環の様子がかわるから、妊娠前に検査しておかないと、正しい見通しがつけにくい。心臓病のある人は出産しようと思つたら、なるべく早く結婚したほうがいい。若いほどよくたえられる。それでも程度によつて妊娠の後半は入院しなければならぬ。自宅にいるときも体重の増加を最小におさえ、息苦しいようなことになつたら、すぐに入院しないといけない。

尿のなかに細菌がみつかるが、自覚症のない無症候性細菌尿の人に、妊娠とわかつたらすぐ治療するか、尿路感染症(腎盂炎やぼうこう炎)をおこしたときに治療するかは、医者の中から意見がわかれてくる。治療をしないでいても、腎盂炎をおこさず無事に出産するのが少なくないからである。以前から細菌尿のあることがわかつている人は、再発するかもしれないが、妊娠する前に治療しておくのほうがいいだろう。

いままで尿路感染をおこしたことのない人が、妊娠16週(5カ月)以後に、ぼうこう炎をおこすことは、まれでない。病気自身は胎児に影響はないが、治療につかう薬には十分注意してもらわねばならぬ。

結核が妊娠中にみつかったてもイソニアジッド、リファンピシン、エタンプトールを併用してなおせる。ストレプトマイシンとピラジナマイドは禁物である。